高职医学生医患沟通障碍成因分析及教学干预策略

田丹洋

（贵州城市职业学院　贵州　贵阳　550025）

摘　要　医患沟通能力是高职医学生适应基层医疗岗位、提升职业竞争力及实现长期职业发展所需的核心能力。当前高职医学生在医患沟通中存在一定障碍，其成因主要包括职业认知偏差、共情能力薄弱及心理素质不足。针对这些成因，可通过课程体系重构纠正职业认知偏差，借助教学方法革新提升共情能力，依托场景化训练强化心理素质。这些教学干预策略能够有效提升高职医学生的医患沟通能力，为基层医疗培养“技术+沟通”复合型人才提供有力支持，对于改善基层医疗服务质量及医患关系具有重要意义。

关键词　高职医学生；医患沟通；沟通能力；教学干预

中图分类号：G712　　**文献标识码**：A　　DOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2025.33.039

Analysis of the Causes of Communication Barriers between Doctors and Patients among Vocational College Medical Students and Teaching Intervention Strategies

TIAN Danyang

(Guizhou City Vocational College, Guiyang, Guizhou 550025)

Abstract　The ability to communicate between doctors and patients is a core skill required for vocational college medical students to adapt to grassroots medical positions, enhance their professional competitiveness, and achieve long-term career development. Currently, vocational medical students face certain obstacles in doctor-patient communication, mainly due to occupational cognitive biases, weak empathy abilities, and insufficient psychological resilience. To address these causes, vocational cognitive biases can be corrected through curriculum restructuring, empathy skills can be enhanced through innovative teaching methods, and psychological resilience can be strengthened through scenario based training. These teaching intervention strategies can effectively enhance the doctor-patient communication skills of vocational medical students, provide strong support for the cultivation of "technology + communication" composite talents in primary healthcare, and are of great significance for improving the quality of primary healthcare services and doctor-patient relationships.

Keywords　vocational college medical students; doctor - patient communication; ability to communicate; teaching intervention

在医疗服务体系中，医患沟通是保障医疗质量、维系良好医患关系的关键环节。基层医疗作为医疗服务的重要组成部分，对医务人员的医患沟通能力有着特殊要求。高职医学生作为基层医疗人才的重要储备力量，其医患沟通能力直接影响着他们在基层医疗岗位的适应与发展。然而，当前部分高职医学生在医患沟通方面表现出一定的不足，难以满足基层医疗实践的需求。深入分析高职医学生医患沟通障碍的成因，并据此提出针对性的教学干预策略，不仅能够丰富医学教育中相关领域的研究，还能为高职医学院校优化人才培养模式、提升学生职业素养提供明确方向，对于推动基层医疗服务水平的提升具有重要的现实价值。

1　医患沟通能力对高职医学生职业发展的核心价值

1.1　保障基层医疗岗位适配性的基础能力

高职医学生的主要就业方向为社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗机构，这些岗位的工作特点决定医患沟通能力是岗位适配的基础。基层患者群体以老年人、慢性病患者为主，其健康认知水平、表达能力存在差异，且对医疗服务的需求更偏向“持续性健康管理”而非单纯的疾病治疗[1]。高职医学生若具备良好的沟通能力，便能够准确理解患者的健康诉求，有效传递疾病预防、康复护理等信息，从而完成从“校园学习”到“岗位实践”的顺利过渡。缺乏这一能力，即便专业技能达标，也可能因无法建立有效的医患互动而影响服务质量，进而难以适应基层医疗岗

中国知网　https://www.cnki.net

位的日常工作要求。

1.2 提升职业竞争力的关键要素

在基层医疗人才市场中，高职医学生面临着与其他层次医学毕业生的竞争，而医患沟通能力是形成差异化竞争优势的关键。基层医疗机构在招聘时，除考察专业技能外，越来越重视应聘者能否快速与患者建立信任关系、能否应对常见的医患沟通场景。具备良好沟通能力的高职医学生，不仅能高效完成诊疗辅助工作，还能通过良好的医患互动提升患者对医疗机构的认可度，这一特质使其在求职及岗位晋升中更易获得青睐。同时，随着基层医疗服务同质化程度的提高，沟通能力已成为衡量职业素养的重要指标，直接影响高职医学生在职业竞争中的综合评价。

1.3 支撑长期职业发展的核心素养

高职医学生的长期职业发展不仅依赖专业技能的积累，还需要以医患沟通能力为基础，增强职业发展的可持续性。在基层医疗工作中，医生与患者的关系具有长期性，多数患者需要长期随访和健康管理，稳定的医患信任关系主要通过持续的有效沟通建立。具备良好沟通能力的高职医学生，能够在长期工作中积累稳定的患者群体，提升职业成就感；同时，良好的沟通能力有助于其协调与上级、同事及其他医疗相关人员的关系，为参与团队医疗、承担管理职责等职业进阶提供支持。而缺乏沟通能力的从业者，可能因医患关系紧张或协作不畅而限制职业发展空间[2]。

2 高职医学生医患沟通障碍的成因分析

2.1 职业认知偏差：对职业能力构成的理解局限

部分高职医学生在专业学习过程中，常将职业能力简单等同于医学技能的掌握程度。这种认知偏差的形成，与高职医学教育中临床技能课程的主导地位有关，也受到传统医学教育中“技术至上”观念的影响。他们普遍认为，只要熟练掌握诊断、治疗等操作技能，就能满足职业需求，却未能认识到医患沟通作为职业能力的重要组成部分，对医疗服务质量的直接影响。这种对职业能力构成的片面理解，使得他们在学习阶段主动忽视沟通能力的培养，进而在实践中缺乏运用沟通技巧的意识，最终导致沟通障碍的出现。

2.2 共情能力薄弱：对患者需求与感受的感知不足

部分高职医学生对患者视角的缺乏代入感，本质上是共情能力薄弱的体现。造成这一问题的原因，既包括他们尚未真正进入临床工作场景、缺乏与患者深度接触的经历，又与医学教育中对患者心理与需求的关注不足相关[3]。他们在学习中更多聚焦于疾病的病理机制与治疗方案，较少思考患者在接受医疗服务时的心理状态与实际需求。由于未能形成理解患者的思维习惯，他们在与患者沟通时，难以准确把握患者的核心诉求，沟通内容自然难以引发患者的认同，沟通效果因此受到影响。

2.3 心理素质不足：对负面沟通场景的应对准备欠缺

部分高职医学生对患者负面情绪的抵触或畏惧，源于心理素质与沟通抗压能力的不足。医学学习阶段的理论化环境，使得他们较少接触真实的医患矛盾场景，缺乏应对负面情绪的经验积累。同时，当前医疗环境中偶发的医患冲突事件，也可能让他们对患者的负面情绪产生心理预设，担心不当回应引发纠纷。这种对负面沟通场景的心理戒备，会使其在沟通中采取回避态度，既无法及时回应患者的情绪需求，又难以理性处理沟通中的分歧，最终形成沟通障碍[4]。

3 高职医学生医患沟通能力培养的教学干预策略

3.1 通过课程体系重构纠正职业认知偏差

高职院校需从人才培养目标出发，重新定位医患沟通课程在医学教育体系中的位置。当前部分高职院校的医学课程仍以临床技能传授为核心，沟通类课程常被边缘化，这直接导致学生形成“技术至上”的职业认知。为改变这一现状，院校应将医患沟通能力培养纳入职业能力培养的核心框架，在人才培养方案中明确其与临床技能课程的同等地位。

具体实施时，可从三个层面推进课程体系调整。其一，增设独立的“医患沟通”必修课，学分设置不低于核心临床课程的三分之一，课程内容需覆盖沟通基础理论、医疗场景沟通规范、基层医疗沟通特点等核心模块，通过系统性教学让学生认识到沟通能力的职业价值。其二，在临床技能课程中嵌入沟通要素。例如，在“诊断学”课程的“问诊”章节中，不仅要求学生掌握问诊的流程与要点，还要训练其如何通过提问引导患者准确描述病情、如何在问诊中兼顾患者情绪；在“外科护理学”的“术前准备”内容中，同步讲解术前告知的沟通技巧，使学生理解技术操作与沟通铺垫的协同关系[5]。其三，开设“基层医疗职业发展”专题课程，邀请基层医疗机构的资深从业者参与授课，通过分析基层医疗岗位的工作实际，说明沟通能力对职业发展的具体影响，如患者信任度提升对职业稳定性的作用、良好沟通对减少基层医疗纠纷的价值等，让学生从职业发展视角重新认识沟通能力的重要性。

3.2 借助教学方法革新提升共情能力

共情能力的培养需突破传统理论讲授的局限，通过教

中国知网 https://www.cnki.net

学方法的系统性革新，引导学生建立理解患者的思维模式。高职医学生共情能力薄弱的主要原因在于，其学习过程长期处于“以疾病为中心”的认知框架中，缺乏“以患者为中心”的视角训练。因此，教学方法革新需围绕“患者视角代入”这一核心目标展开。

首先，在专业课程教学中增加“患者需求分析”环节。教师在讲解疾病诊疗知识时，可结合疾病特点设计相关讨论题，如在“糖尿病治疗”章节中，引导学生思考“长期服药的患者可能面临哪些心理压力？”“农村患者在血糖监测中可能遇到哪些实际困难？”等问题，通过课堂讨论让学生意识到患者除疾病本身外的其他需求。这一环节无须额外增加课时，可融入现有课程的案例分析部分，使患者需求分析成为专业学习的自然延伸。

其次，引入“角色转换”体验式教学。院校可搭建模拟诊疗场景，让学生轮流扮演患者、家属与医生三种角色。在扮演患者时，学生需根据设定的病情背景（如老年慢性病患者、经济条件有限的患者等），表达自身的健康诉求与顾虑；扮演家属时，需模拟对患者病情的担忧与对治疗效果的期待；扮演医生时，则需在回应诉求的过程中体会沟通的难点。每次体验后，由教师引导学生分享角色感受，重点分析“作为患者时最希望医生了解的信息”“作为医生时如何回应才能让患者感到被理解”，通过亲身体验强化对患者视角的感知。

最后，建立“患者故事库”辅助教学。院校可收集基层患者的真实就医经历（隐去个人信息），整理成文字或音频材料，作为教学素材使用。在教学中，教师可引导学生分析材料中患者的情绪变化、需求表达特点，讨论如何通过沟通回应这些需求。这些真实故事能够让学生接触到更具体的患者心理状态，避免共情训练陷入抽象化。

3.3 依托场景化训练强化心理素质

面对患者负面情绪时的心理素质，需通过有针对性的场景化训练逐步培养。高职医学生对负面情绪的抵触或畏惧，本质上是缺乏应对经验与方法储备的表现。场景化训练需构建“模拟实践－反馈改进－能力固化”的闭环，帮助学生建立应对负面沟通场景的心理准备与方法体系。

场景设计需贴合基层医疗的常见沟通矛盾。基层医疗中患者负面情绪的产生多与治疗效果、费用、就医便利性等因素相关，因此训练场景可包括“患者质疑药物疗效”“家属对检查项目费用提出异议”“慢性病患者因长期治疗产生抱怨”等典型情境。每个场景需明确患者情绪表现（如语气生硬、言辞不满、情绪激动等）、核心诉求与潜在顾虑，为训练提供具体框架。

训练实施可分为三个阶段。第一阶段为“引导式训练”，由教师示范应对方法，如面对费用异议时，可先认可患者的顾虑（“我理解您对费用的考虑”），再解释检查的必要性（“这个检查能帮助我们更准确地判断病情，避免盲目用药”），学生模仿练习并熟悉基础回应逻辑。第二阶段为“自主应对训练”，学生在设定场景中独立与“模拟患者”沟通，教师通过录像记录过程，训练后回放分析，指出回应中的优点与不足，重点纠正回避、辩解等不当应对方式。第三阶段为“压力升级训练”，逐步增加场景的复杂程度，如在患者质疑的同时加入家属的情绪激动，或在沟通中引入时间限制，通过适度提升压力强度，增强学生的心理适应能力。

训练过程中需同步强化心理引导。教师应向学生明确，患者的负面情绪多源于对病情的担忧或对医疗的不了解，而非针对医生个人，帮助学生建立对负面情绪的理性认知。同时，总结应对负面情绪的基本步骤，如“先接纳情绪再解决问题”“用事实回应质疑”“主动说明后续措施”等，让学生掌握可操作的应对框架，减少面对负面情绪时的无助感。

4 结语

高职医学生医患沟通障碍的形成是多种因素共同作用的结果，职业认知、共情能力和心理素质方面的不足，制约其沟通能力的提升。而基于这些成因提出的课程体系重构、教学方法革新及场景化训练等教学干预策略，为解决高职医学生医患沟通问题提供可行路径。通过这些策略的有效实施，有望系统提升高职医学生的医患沟通能力，使其更好地契合基层医疗岗位的需求。

参考文献

[1] 周素芳,李国庆,黄新云,等.CORID教学模式在《医患沟通》课程思政教学中的实践初探[J].才智,2025(16):81-84.

[2] 温兰英,谢莉萍,黄建国,等.视频案例+体验式教学法在耳鼻咽喉科医患沟通教学实践中的应用[J].卫生职业教育,2025,43(11):41-44.

[3] 庹媛媛,艾戎,张涛,等.角色扮演法在儿科医患沟通教学中的应用效果[J].贵州医科大学学报,2025,50(5):775-780.

[4] 鲁凤丽,王羽丰,刘坤,等.PBL与TBL联合教学法在规培学员医患沟通教学中的应用研究[J].云南医药,2025,46(3):52-54.

[5] 钟庆华,宁月,罗丽艳,等.以岗位胜任力为导向的儿科医患沟通能力培养应用研究[J].中国高等医学教育,2025(5):33-35.

中国知网 https://www.cnki.net